

Wspieranie osoby autystycznej monotropowej na przestrzeni życia

Przewodnik dla praktyków i personelu medycznego

Cel. Ten przewodnik wyjaśnia, czym jest autystyczny monotropowy umysł, jak jego cechy zmieniają się na przestrzeni życia i jak praktycy oraz personel medyczny mogą **interagować z, stymulować (angażować) i wspierać** ludzi autystycznych od wczesnego dzieciństwa do późnej starości. Opiera się na teorii **monotropizmu** autyzmu — opisie opartym na uwadze i neuroafirmującym, rozwiniętym przez autystycznych badaczy Dinah Murray, Wenn Lawson i Mike Lesser (2005) — oraz na evidencji recenzowanej i wytycznych klinicznych/praktycznych tam, gdzie istnieją. Nie zastępuje zindywidualizowanej oceny; każdy człowiek autystyczny jest inny.

Uwaga o języku. Ten przewodnik używa **języka identyfikacji-pierwszej** („osoba autystyczna”), co jest preferencją większości społeczności autystycznej i spójne z teorią źródłową. Niektórzy ludzie i rodziny preferują język osoba-pierwsza („osoba z autyzmem”); podążaj za preferencją jednostki. Przewodnik celowo unika terminów opartych na deficycie („zaburzony”, „deficytowy”, „objaw”) z wyjątkiem cytowania kryteriów klinicznych, a zamiast tego opisuje różnice z mocnymi i wyzwaniem. Monotropizm to jedna lens; mniejszość ludzi autystycznych nie czuje, że ich opisuje, i powinien uzupełniać, nie zastępować, słuchanie jednostki.

Część 1 — Czym jest autystyczny monotropowy umysł?

Monotropizm proponuje, że umysły działają jako **system zainteresowań**: jesteśmy przyciągani do wielu rzeczy, te zainteresowania ciągną naszą uwagę, a **uwaga jest ograniczonym zasobem**, o który procesy mentalne konkurują (Murray, Lesser & Lawson, 2005). Różnica między kognicją autystyczną a nie-autystyczną jest ramiona jako różnica w *tym, jak uwaga jest alokowana*, nie deficyt.

"W dowolnym momencie ilość uwagi dostępnej dla świadomej jednostki jest ograniczona. Istnieje konkurencja między procesami mentalnymi o ten rzadki zasób." — Murray, Lesser & Lawson (2005), przez National Autistic Society (NAS, 2025).

Monotropowy umysł ma tendencję do aktywowania **mniejszej liczby zainteresowań naraz**, ale każde aktywne zainteresowanie chwytą **nieproporcjonalny, intensywny udział** zasobów przetwarzania, produkując wąski, głęboki „**tunel uwagi**”. Wszystko poza tunelem jest przetwarzane minimalnie. Umysł **polytropowy** (częstszy, nie-autystyczny tryb) rozkłada uwagę na więcej zainteresowań i przełącza między nimi bardziej płynnie (Murray, Lesser & Lawson, 2005; F. Murray, 2018).

Teoria robi trzy główne predykcje, które mapują się na codzienne autystyczne doświadczenie (F. Murray, 2018; Dwyer, 2025; NAS, 2025):

1. **Intensywność wewnątrz tunelu** — żywy, głęboki fokus, który wspiera ekspertyzę, kreatywność i stany **flow**.
2. **Zmniejszone przetwarzanie poza tunelem** — bodźce, sygnały społeczne, a nawet sygnały wewnętrzne (głód, ból, potrzeby toaletowe) mogą się nie rejestrować.
3. **Trudność przełączania** — przejścia między stanami uwagi są powolne i pracochłonne; to jest **autystyczna bezwładność**.

1.1 Charakterystyczny profil na pierwszy rzut oka

Domena	Cecha zinformowana monotropizmem
Uwaga / zainteresowanie	Głęboki, wąski fokus; mało jednoczesnych ścieżek; „specjalne zainteresowania” są centralne, radosne i znaczące, nie peryferyjne

Domena	Cecha zinformowana monotropizmem
Sensoryka	Hiper-reaktywność (intruzyjny bodziec uchwycony w tunelu jest odczuwany intensywnie); hipo-reaktywność (kiedy absorbowany gdzie indziej, bodźce/ból mogą się nie rejestrować); szukanie sensoryczne (przyjemny bodziec w tunelu jest intensywnie ścigany) — <i>ujednolicone</i> wyjaśnienie
Interocepcja i ciało	Zmniejszona świadomość głodu, pragnienia, bólu, zmęczenia, potrzeb toaletowych w flow („rozłączenie interoceptywne”)
Przełączanie / funkcja eksekutywna	Autystyczna bezwładność — trudność rozpoczynania, zatrzymywania lub zmiany ścieżki; nie generyczna „dysekskutywna dysfunkcja”
Społeczne / komunikacja	Wielokanałowe przetwarzanie społeczne jest kosztowne; dosłowna interpretacja; potrzeba czasu przetwarzania; problem podwójnej empatii oznacza, że niezrozumienie jest <i>bidirectionalne</i> , nie deficyt autystyczny
Rutyny i stimming	Rutyny redukują konkurujące decyzje i obciążenie mentalne; stimming dostarcza przewidywalny, samokontrolowany input, który filtruje przeciążenie i przywraca równowagę
Mocne strony	Ekspertyza, znajdowanie wzorców, podtrzymana koncentracja, flow, szczerość, głębia wiedzy, kreatywne zanurzenie

1.2 Ryzyka dla dobrostanu, które z tego wynikają

Zrozumienie *mechanizmu* czyni ryzyka przewidywalnymi i — kluczowo — unikaniem:

- **Monotropic split** (termin ukuty przez Tanya Adkin): mentalna dysonans i wyczerpanie z bycia zmuszonym do dzielenia lub szybkiego przełączania uwagi polytropowo; może „mieć katastrofalne skutki i krótko- i długoterminowo” (F. Murray, 2023).
- **Meltdowns i shutdowns** to **nieświadome** reakcje układu nerwowego na przytłoczenie, nie wyborów behawioralnych ani „złości”. **Meltdown** jest widoczny (płacz, krzyk, chodzenie tam i z powrotem, stimming, próby ucieczki); **shutdown** to wewnętrzne odbicie lustrzane — wycofanie, brak reaktywności, rozłączenie, ochronne „wyłączenie”, by zachować energię (Autism Society, 2025; Leicestershire Partnership NHS Trust; Reframing Autism). Oba

wymagają istotnego **czasu regeneracji** (czasem dni) i są pogarszane przez brak zrozumienia innych.

- **Autystyczny burnout** to „zespół ... wynikający z przewlekłego stresu życiowego i niedopasowania oczekiwań i zdolności bez odpowiednich wsparć”, charakteryzujący się **ogarniającym, długoterminowym (typowo 3+ miesiące) wyczerpaniem, utratą funkcji i zmniejszoną tolerancją na bodziec** (Raymaker et al., 2020). Jest **odrębny od burnoutu zawodowego i depresji klinicznej**, jest powiązany z **zachowaniami samobójczymi**, i jest pogarszany przez nauczanie **maskowania/kamuflowania** cech autystycznych. Regeneracja jest związana z **akceptacją i wsparciem społecznym, czasem wolnym / zmniejszonymi oczekiwaniami, i „robieniem rzeczy w autystyczny sposób” / odmaskowaniem** (Raymaker et al., 2020).
- **Maskowanie / kamuflaż** (ukrywanie cech autystycznych, by wydawać się nie-autystycznym) jest wyczerpujące i jest związane z lękiem, depresją i przegapioną diagnozą — szczególnie wśród dziewcząt i kobiet, częściej socjalizowanych do maskowania (F. Murray, 2023; Pearson & Rose, 2021; Bradley et al., 2021).
- **Ruminacja / „pętle zmartwień”**: to samo tunelowanie, które produkuje głębokie zainteresowanie, może się fiksować na zmartwieniach i lękach (Hallett, 2021; F. Murray, 2023).

1.3 Status evidencji (bądź uczciwy z sobą i klientami)

Monotropizm silnie rezonuje z autystycznym doświadczeniem żywym i jest coraz częściej cytowany w badaniach, ale pozostaje teorią **deskryptywną** z ograniczonym bezpośrednim testowaniem eksperymentalnym i niedojrzałą bazą pomiaru — **Monotropism Questionnaire** (Garau et al., 2023) jest jedynym dedykowanym narzędziem i wciąż dojrzewa (Dwyer, 2021; Dwyer, 2025). Wspierająca zbieżna evidencja obejmuje „lepkie” / spowolnione odłączanie uwagi u dzieci autystycznych (Landry & Bryson, 2004; metaanaliza: Sacrey et al., 2015) i wschodzącą literaturę o **autystycznym flow** (Heasman et al., 2024). Traktujcie monotropizm jako potężną *heurystykę kliniczną* — nie etykietę diagnostyczną.

Część 2 — Zasady przekrojowe dla każdego praktyka

Przed sekcjami według wieku, te zasady obowiązują **na każdym etapie życia i w każdym kontekście**. Są one praktycznym rdzeniem tego, „jak dobrze interagować i postępować” z osobą monotropową.

1. **Spotkaj ich tam, gdzie jest ich uwaga.** Najczęściej cytowana praktyczna implikacja monotropizmu to pracować z aktualnym zainteresowaniem osoby raczej niż przeciwko niemu. Zainteresowania są „dźwignią”, nie przeszkodami do przekierowania (F. Murray, 2018; Wood, 2019; Lawson). *„Traktujcie zainteresowania jako coś, z czym pracować”* (F. Murray, 2018).
2. **Chroń tunel uwagi; minimalizuj „monotropic split”.** Unikajcie przerw, wymuszonego szybkiego przełączania zadań i niepotrzebnego multitaskingu. Gdy przełączenie jest nieuniknione, dajcie **ostrzeżenia i czas przejścia** (patrz §3). Jak autystyczny inżynier Jamie Knight ramuje planowanie w pracy: budujcie **„tunele, nie zadania”**, i pozwólcie *środowisku otworzyć przestrzeń dla tunelu, by przeszedł*, raczej niż zmuszać osobę do przewiercenia się przez niego (Knight, 2021/2022).
3. **Szanujcie głębokie zainteresowania jako zasoby dobrostanu.** Specjalne zainteresowania dostarczają radości, stabilności, tożsamości, nauki i regeneracji od burnoutu; nie są „obsesjami” do ograniczania (F. Murray, 2023; Mantzalas et al., 2022). Redukowanie dostępu do nich jest ryzykiem klinicznym, nie leczeniem.
4. **Redukujcie niepotrzebne obciążenie sensoryczne** i projektujcie dostępne środowiska (mniej hałasu/.bałaganu wizualnego; pozwalajcie ciche, słabo oświetlone przestrzenie; unikajcie fluorescentnego odblasku i silnych zapachów, gdy możliwe) (NAS, 2025; F. Murray, 2023).
5. **Komunikujcie się jasno i dosłownie.** Mówcie, co macie na myśli; unikajcie sarkazmu, pośrednich żądań i silnej zależności od tonu/wyrazu samego; dajcie **dodatkowy czas przetwarzania**; oferujcie informacje na piśmie. Nie równajcie powolnej odpowiedzi z brakiem zainteresowania lub brakiem zrozumienia (F. Murray, 2023).
6. **Praktykujcie postawę podwójnej empatii.** Uznajcie, że przerwy w komunikacji są **bidirectionalne** (Milton, 2012). Kiedy coś idzie źle w interakcji, zapytajcie, co wy możecie przegapić, raczej niż przypisywać to deficytowi osoby autystycznej.

7. **Wspierajcie sprawczość i autentyczność; nie wymuszajcie maskowania.** Redukujcie presję, by „przejsć” za nie-autystycznego. Tłumienie stimów lub naturalnej komunikacji jest szkodliwe (F. Murray, 2023; Raymaker et al., 2020; Pearson & Rose, 2021).
 8. **Budujcie przewidywalność i rutyny z osobą, nie *nad* nią.** Narzucone rutyny często się odwrotnie odbijają; współtworzone rutyny redukują obciążenie decyzji i są mile widziane (F. Murray, 2022).
 9. **Planujcie regenerację.** Po wydarzeniach o wysokiej wymaganości (wizyty kliniczne, przejścia, wymagania społeczne), oczekujcie i pozwalajcie czas wolny, stimming i dostęp do zainteresowań.
 10. **Słuchajcie jednostki jako eksperta własnego doświadczenia.** Samoopis jest dowodem pierwotnym; Monotropism Questionnaire (Garau et al., 2023) może być użytecznym *rozrusznikiem rozmowy*, nie diagnozą.
-

Część 3 — Przewodnik na przestrzeni życia

Każda sekcja obejmuje: **(a) co możecie obserwować, (b) jak interagować, (c) jak stymulować / angażować, i (d) jak wspierać / radzić sobie z wyzwaniami.**

3.1 Wczesne dzieciństwo (mniej więcej 0–5 lat)

(a) Co możecie obserwować. Intensywny fokus na specyficznych obiektach/tematach; wcześnie pojawiające się intensywne zainteresowania (często pojawiające się wcześniej niż u dzieci nie-autystycznych); ustawianie w rzędzie, sortowanie, kategoryzowanie i tworzenie wzorców jako zabawa; zmniejszona lub atypowa uwaga dzielona i reakcja na imię; **spowolnione odłączanie uwagi** („lepki wzrok”) — mierzalne od niemowlęctwa i jeden z najwcześniejszych znaków; hiper- lub hipo-reaktywność sensoryczna; rutyny i powtarzalna zabawa; meltdowny przy przejściach. Monotropowy maluch może być głęboko absorbowany i przegapić wiele poza tunelem, włączając głód, ból lub rodzica wychodzącego z pokoju (Landry & Bryson, 2004; F. Murray, 2023; Donzelli, 2021; Lawson, o trwałości obiektu).

(b) Jak interagować. Wejdźcie w tunel uwagi dziecka raczej niż wyciągajcie je z niego — **dołączcie do jego zabawy i zainteresowania najpierw**, potem łagodnie rozszerzajcie stamtąd. Użyjcie zainteresowania, by budować połączenie i uwagę dzielona (Lawson). Utrzymujcie język jasny, powolny i dosłowny; pozwalajcie czas przetwarzania; nie wymuszajcie kontaktu wzrokowego (kontakt wzrokowy sam może zużywać rzadkie zasoby uwagi) (F. Murray, 2023). Redukujcie obciążenie sensoryczne w pokoju.

(c) Jak stymulować / angażować. Użyjcie **intensywnego zainteresowania dziecka jako pomostu do nauki i budowania umiejętności** — sekwencjonowanie, język, liczenie, umiejętności motoryczne i zabawowe mogą być wszystkie ćwiczone *przez* zainteresowanie (Lawson; Wood, 2019; BERA, o stanach flow w klasie). Wspierajcie wschodzącą **uwagę dzieloną** przez zabawę prowadzoną zainteresowaniem i opartą na relacji oraz wczesną interwencję (model JASPER i podobne podejścia oparte na zainteresowaniu/zabawie celują w uwagę dzieloną i zabawę symboliczną; Kasari et al., 2006). Szanujcie **kulturę autystycznej zabawy** — ustawianie w rzędzie, sortowanie i eksploracja sensoryczna to ważna zabawa, nie „zła” zabawa do poprawiania (Donzelli, 2021).

(d) Jak wspierać / radzić sobie. Zarządzajcie **przejściami** z wizualnymi harmonogramami/minutnikami, odliczaniem, ostrzeżeniami werbalnymi + wizualnymi *przed* zmianą, obiektami „pomostowymi” od jednej czynności do następnej i dodatkowym czasem; nigdy gwałtownie nie wyciągajcie dziecka z tunelu uwagi (Autism Little Learners; F. Murray, 2023). Na **meltdowny**: zachowajcie spokój, redukujcie stymulację, nie oceniacie i nie karajcie — są nieświadome; zapewnijcie bezpieczeństwo, potem pozwalajcie regenerację (Autism Society, 2025). Chronie dostęp do stymingu (to samoregulacja) (F. Murray, 2023). Unikajcie programów opartych na complyansie, które odtresowują stymy lub naturalne zachowania: te zwiększają maskowanie i długoterminową szkodę (F. Murray, 2023; Raymaker et al., 2020).

3.2 Dzieciństwo w wieku szkolnym (mniej więcej 6–12 lat)

(a) Co możecie obserwować. Szkoła jest często pierwszym utrwalonym testem naprężenia systemu monotropowego i jest „piekłem dla wielu monotropowych dzieci — nawet jeśli wielu z nas lubi uczyć się” (F.

Murray, 2023). Sala lekcyjna, korytarze i przerwy są typowo **zbyt głośne, zbyt wizualnie zajęte i zbyt nieprzewidywalne**, konsumując uwagę, która powinna iść na naukę. Dzieci mogą wydawać się „źle zachowywać” przy przejściach, wycofywać się na przerwach, być zastraszane za „dziwne” zainteresowania lub zabawę autokierowaną, lub być źle rozumiane przez personel jako oporne, leniwe lub niezainteresowane. Bezwładność objawia się jako trudność z rozpoczynaniem pracy, zmianą przedmiotu lub pakowaniem. Niektóre dzieci zaczynają tu mocno maskować, z kosztami zdrowia psychicznego (F. Murray, 2023; Leatherland, 2019; NAS, 2025).

(b) Jak interagować (nauczyciele, pielęgniarzki szkolne, terapeuci).

Rozpoznajcie, że opór przy przejściach to problem **kognitywnego kosztu**, nie oporu. Dostarczajcie cichych/słabo oświetlonych przestrzeni (np. „prace” w bibliotece na przerwie, spokojny kącik). Budujcie relacje przez zainteresowanie dziecka. Komunikujcie się dosłownie, z wyprzedzeniem i na piśmie, gdy możliwe. Modelujcie postawę podwójnej empatii dla rówieśników i kolegów — ramujcie różnice jako różnice, nie deficyty (F. Murray, 2023; Wood, 2019).

(c) Jak stymulować / angażować („monotropowy curriculum”).

Zróbcie **specjalne zainteresowanie kręgosłupem nauki**: uczcie czytania, pisanie, matematyki, historii i nauki *przez* nie; pozwalajcie przedłużony czas w flow prowadzonym zainteresowaniem; projektujcie zadania wokół mniejszej liczby głębszych ścieżek raczej niż ciągłego przełączania (Wood, 2019, „intensywne zainteresowania ... klucz do inkluzji edukacyjnej”; F. Murray, „Monotropism at School”, 2019; BERA). Stany flow to stany nauki — chrońcie je: *„jeśli uczeń czuje się przytłoczony ... i wiecie, że ma monotropowe zainteresowanie Lego, dlaczego nie stworzyć cichą przestrzeń ... i pozwolić mu przedłużony czas?”* (BERA). Łączcie się z pasjonującym autystycznym uczniem *przez* pasję (Wood et al., 2022; Lawson).

(d) Jak wspierać / radzić sobie. Używajcie wizualnych

harmonogramów, ostrzeżeń o przejściach i aktywności pomostowych; dajcie hojny czas przejścia i redukujcie liczbę przejść na dzień, gdy możliwe (Autism Little Learners; F. Murray, 2023). Współtwórzcie rutyny z dzieckiem. Obserwujcie **autystyczny burnout i „regresję umiejętności”** u dzieci w wieku szkolnym — te często odzwierciedlają przytłoczenie i przesunięcie zasobów uwagi, nie utratę wrodzonej

zdolności, a odpowiedzią jest **redukcja żądań i przywrócenie dostępu do zainteresowań/odpoczynku**, nie pchanie mocniej (Edgar, 2024; Raymaker et al., 2020). Identyfikujcie i redukujcie presję maskowania, zwłaszcza u dziewcząt, które są często pomijane w diagnozie, bo maskują (F. Murray, 2023). Używajcie przewodnika burnoutu dla nauczycieli (np. Edgar, 2023) i konsultujcie rodziców jako ekspertów swojego dziecka.

3.3 Młodzież (mniej więcej 13–18 lat)

(a) Co możecie obserwować. Dojrzewanie przynosi zmiany hormonalne i mózgowe (przycinanie synaptyczne, mielinizacja), które mogą intensyfikować reakcje sensoryczne i emocjonalne i zaburzać ugruntowaną równowagę. Społeczne wymagania młodzieży — zmienne hierarchie rówieśnicze, niejawne zasady społeczne, randki, formowanie tożsamości — są ekstremalnie wielokanałowe i wyczerpujące dla systemu monotropowego. Trudności zdrowia psychicznego (lęk, depresja) osiągają tu szczyt; ruminacja / „pętle zmartwień” może się ugruntować; kamuflaż się intensyfikuje, a wiele autystycznych dziewcząt i młodzieży zmarginalizowanych płci jest **identyfikowanych po raz pierwszy tylko w kryzysie**. Specjalne zainteresowania stają się centralne dla tożsamości i regeneracji. Przyjaźnie, gdy wysokiej jakości, są ochronne dla zdrowia psychicznego (ARI, o dojrzewaniu; Autism Awareness Australia; F. Murray, 2023; Hallett, 2021; Sedgewick/Cook et al., przez PMC9597130).

(b) Jak interagować. Traktujcie młodą osobę jako eksperta własnego doświadczenia. Używajcie jasnej, dosłownej, pełnej szacunku komunikacji; dajcie czas przetwarzania i opcje na piśmie. Walidujcie zainteresowania jako legitymne i kształtujące tożsamość. Bądźcie czuli na problem podwójnej empatii w interakcjach rówieśniczych i klinicznych. Dostarczajcie **przewidywalności** wokół spotkań i redukujcie niepotrzebne obciążenie społeczne/sensoryczne (Autism Awareness Australia; F. Murray, 2023).

(c) Jak stymulować / angażować. Kierujcie specjalne zainteresowania w **naukę, projekty, portfolio, wolontariat i wczesną eksplorację kariery** — są największym motywacyjnym i kompetencjotwórczym atutem młodego człowieka. Wspierajcie **tożsamość i społeczność**: autystyczne grupy rówieśnicze, kluby specjalnych zainteresowań, mentoring i

online'owe autystyczne społeczności mogą transformować dobrostan. Uczcie **samo-zrozumienia** monotropizmu, by młoda osoba mogła advokować za swoimi potrzebami uwagi (zamiast internalizować „jestem leniwy/zepsuty”).

(d) Jak wspierać / radzić sobie. Proaktywnie adresujcie **zdrowie psychiczne**; screenijcie na lęk, depresję, burnout i samobójczość, rozpoznając, że **autystyczny burnout jest odrębny od depresji** i od burnoutu zawodowego i wymaga *zmniejszonych żądań, akceptacji i odmaskowania*, nie tylko CBT lub antydepresantów (Raymaker et al., 2020). Wspierajcie dojrzewaniowe praktyczne i sensoryczne potrzeby (miesiączkowanie, higiena, zmiany ciała) explicitnie i konkretnie (ARI). Adresujcie **szkodę kamuflażu** — explicitnie redukujcie oczekiwania maskowania. Uczcie samozarządzanie meltdown/shutdown i zapewnijcie, że młoda osoba ma drogę regeneracji o niskiej wymaganości. Planujcie **przejścia w dorosłość** (edukacja, praca, przekazanie zdrowotne) wcześniej i z zainteresowaniami młodej osoby w centrum. *(Inferencja, oznaczona: większość wytycznej klinicznej tutaj jest extrapolowana z literatury dorosłej o burnoucie/maskowaniu i relacjach autystycznego doświadczenia żywego, raczej niż z RCT specyficznych dla młodzieży.)*

3.4 Dorosłość (mniej więcej 19-połowa życia)

(a) Co możecie obserwować. Wielu dorosłych autystycznych — zwłaszcza kobiety, osoby kolorowe i ci bez niepełnosprawności intelektualnej — jest **diagnozowanych dopiero w dorosłości** („zagubione pokolenie”, Lai & Baron-Cohen). W odpowiednim środowisku monotropowi dorośli wnoszą **głębką ekspertyzę, podtrzymaną koncentrację, niezawodność, znajdowanie wzorców i szczerść**, które są genuine atuty. W złym środowisku — biura open-plan, ciągłe przerwania, niejasne oczekiwania, obciążenie sensoryczne, żądania społeczno-polityczne — stają w obliczu przewlekłego wyczerpania, maskowania, meltdownów/shutdownów i **autystycznego burnoutu** (Knight, 2021/2022; Booth, 2021; Raymaker et al., 2020; Mantzalas et al., 2022).

(b) Jak interagować. Komunikujcie się **explicitnie i na piśmie**; definiujcie oczekiwania, terminy i normy społeczne konkretnie, raczej niż implikujcie. Pozwalajcie komunikację na piśmie/asynchroniczną

(email, SMS), która redukuje obciążenie kanału. Dajcie czas przetwarzania; nie czytajcie pauzy jako oporu. Pytajcie osobę, jakie adaptacje pomagają — ona jest ekspertem (F. Murray, 2023; Knight, 2021).

(c) Jak stymulować / angażować (środowisko pracy). Strukturyzujcie rolę wokół **mniejszej liczby głębszych „tuneli, nie zadań”** (Knight, 2021): minimalizujcie spotkania i przerwania, batchujcie płytką pracę, pozwalajcie czas flow i dajcie dostęp do cichego/sensorycznie kontrolowanego miejsca. Dopasowujcie zadania do **mocnych stron i specjalnych zainteresowań**; intensywność autystycznego fokusu, gdy chroniona, jest głównym atutem produktywności i innowacji (Advanced Autism Services, 2025; Sachs Center; Booth, 2021). Budujcie **rutyny** z dorosłym i używajcie adaptacji prawnie dostępnych (np. ADA/Equality Act) (Linki ABA). Zachęcajcie do „**życia mało**”, gdy pomocne — upraszczanie życia do kilku obszarów fokusu może zauważalnie poprawić funkcję i szczęście (Knight, 2021).

(d) Jak wspierać / radzić sobie. Traktujcie **autystyczny burnout** jako poważną, odrębną jednostkę kliniczną: rozpoznawajcie przewlekłe wyczerpanie, utratę uprzednio posiadanych umiejętności i zmniejszoną tolerancję na bodziec; oceniajcie samobójczość (Raymaker et al., 2020). Kierunek regeneracji wsparty evidencją to **redukcja żądań i oczekiwań, dostarczenie akceptacji i wsparcia społecznego, i pozwalanie „robienia rzeczy w autystyczny sposób” / odmaskowania** (Raymaker et al., 2020; Mantzalas et al., 2022). *Nie* przepisujcie opartego na maskowaniu treningu umiejętności społecznych jako rozwiązania. Adresujcie współwystępujące lęk, depresję, ADHD, sen i warunki GI (które są częstsze u dorosłych autystycznych). Szanujcie, że **specjalne zainteresowania są ochronne i regeneracyjne**, nie kompulsje do ograniczania (Mantzalas et al., 2022).

3.5 Starsi dorośli i seniorzy (mniej więcej 60+)

(a) Co możecie obserwować — i uczciwe granice naszego wiedzenia. To jest **najmniej zbadana część autystycznego życia**: według 2024, badania nad starszymi dorosłymi autystycznymi stanowiły tylko około **0,4% literatury o autyzmie** (choć rosnące ~392% od 2012) (Klein et al., 2024). Istniejąca evidencja jest niepokojąca: wyniki dla starszych dorosłych autystycznych są **ogólnie słabe** we wszystkich czterech

domenach „dobrego starzenia się” (zdrowie i funkcjonowanie; funkcjonowanie kognitywne i fizyczne; pozytywny afekt i kontrola; uczestnictwo społeczne). Pokazują **więcej warunków medycznych, niskie umiejętności adaptacyjne, podwyższone ryzyko pogorszenia kognitywnego, ograniczoną aktywność fizyczną, wysokie stopy warunków zdrowia psychicznego, niską jakość życia i zmniejszone społeczne/community'owe uczestnictwo** (Klein et al., 2024). W australijskiej próbie (wiek 40+), tylko **3,3% spełniało kryteria „udanego starzenia się”** (Klein et al., 2024). Starsi dorośli autystyczni mają **wyższe stopy większości warunków zdrowotnych** — zaburzenia nastroju, problemy ze snem, warunki GI i kardialne — niż nie-autystyczni rówieśnicy (Additude, podsumowując studia populacyjne). Wielu starszych ludzi autystycznych jest **niediagnozowanych** („zagubione pokolenie”); klinicyści muszą być gotowi rozpoznać autyzm u starszych dorosłych prezentujących z lifelong'owymi społeczno/sensorycznymi różnicami, burnoutem lub kryzysem zdrowia psychicznego (OAR; Klein et al., 2024).

(b) Jak interagować. Wszystkie zasady przekrojowe obowiązują ze zwiększoną wagą: jasna, dosłowna, pełna szacunku komunikacja; pozwalajcie obfity czas przetwarzania i informacje na piśmie; redukujcie obciążenie sensoryczne (zmiany słuchu i wzroku kumulują się z baseline'owymi różnicami sensorycznymi); nigdy nie zakładajcie kognitywnej niezdolności z powolnej lub atypowej odpowiedzi. Uwzględniajcie **problem podwójnej empatii** explicitnie w kontekstach opieki.

(c) Jak stymulować / angażować. Zachowajcie i **chrońcie lifelong'owe specjalne zainteresowania i rutyny** — te są kotwice tożsamości, kognicji i dobrostanu i mogą być szczególnie ochronne, gdy inne zdolności się zmieniają. Adaptujcie aktywności do **zmieniających się zdolności fizycznych i sensorycznych** raczej niż usuwając je. Wspierajcie **autystyczną społeczność i połączenie**, by kontrastować poważną izolację społeczną widzianą w tej grupie (Klein et al., 2024; OAR). Zachęcajcie do łagodnej aktywności fizycznej dostosowanej do osoby (fizyczna nieaktywność jest zidentyfikowanym problemem) (Klein et al., 2024).

(d) Jak wspierać / radzić sobie.

- **Dostęp do opieki zdrowotnej** jest krytyczną luką: wielu starszych dorosłych autystycznych unika opieki z powodu lifelong'owych negatywnych doświadczeń i barier sensorycznych/komunikacyjnych; kliniki potrzebują szkolenia (OAR; patrz Część 4).
- Obserwujcie **autystyczny burnout** — ryzyko kumuluje się przez dekady maskowania i niezaspokojonego zapotrzebowania i może być błędnie odczytane jako depresja lub „spadek związany z wiekiem” (Raymaker et al., 2020).
- Bądźcie czuli na **zmianę kognitywną vs autystyczną różnicę**: rozróżnianie autystycznych monotropowych/bezwładnych wzorców od genuine **demencji/pogorszenia kognitywnego** jest klinicznie trudne i słabo zbadane; nie zakładajcie. Jest *bardzo ograniczone* badanie na autyzm + demencja/Alzheimer — zaznaczcie niepewność i oceniajcie ostrożnie (ABTAB; Klein et al., 2024).
- **Środowiska opieki** (domy opieki, szpitale) są często sensorycznie wrogie i zakłócające rutynę; advokujcie za cichymi przestrzeniami, przewidywalnymi rutynami, zatrzymaniem znaczących obiektów/zainteresowań i szkoleniem personelu o autyzmie.
- Wspierajcie **opiekę na końcu życia i planowanie z wyprzedzeniem** z jasną, dosłowną komunikacją i szacunkiem dla autonomii.
- *Inferencja, oznaczona*: Ponieważ specyficzna dla autyzmu ewidencja w podeszłym wieku jest rzadka, większość tej sekcji stosuje model monotropizmu na przestrzeni życia plus ogólne ustalenia o starzeniu-z-autyzmem; traktujcie jako wytyczną najlepszej praktyki, nie ugruntowany protokół.

Część 4 — Specyficzne wytyczne dla personelu medycznego

Środowiska medyczne (jasne światła fluorescentne, nieprzewidywalne oczekiwania, niejasne instrukcje, sensoryczne i społeczne wymagania, ból i inwazyjność) są wśród najtrudniejszych środowisk dla ludzi monotropowych i często wyzwalają shutdowny, meltdowny i unikanie opieki (Autism Society, 2025; PMC11305600 narracyjny przegląd o autyzm-przyjaznej opiece zdrowotnej). Poniższe jest zaczerpnięte z

literatury autyzm-przyjaznej opieki i **AASPIRE Healthcare Toolkit / Autism Healthcare Accommodations Tool (AHAT)** (autismandhealth.org).

Przed wizytą

- **Oferujcie kwestionariusz przed-wizytowy / AHAT**, by uchwycić specyficzne sensoryczne, komunikacyjne i proceduralne potrzeby jednostki i wyprodukować personalised raport adaptacji (AASPIRE).
- **Dostarczajcie na piśmie, dosłownie informacje** o tym, co się stanie, w jakiej kolejności i jak długo potrwa; oferujcie zdjęcia pokoju/personelu, gdy możliwe.
- **Oferujcie wybory planowania**: pierwszy/ostatni termin (najspokojniejszy), krótsze oczekiwanie, bez nakładających się głośnych klinik.
- Pozwalajcie osobie **przynieść zaufanego wsparcia** i własny **kit sensoryczny** (słuchawki redukujące hałas, okulary przeciwsłoneczne, fidget) (CHOP; Grateful Care ABA).

Podczas wizyty

- **Redukujcie obciążenie sensoryczne**: przyciemnione lub miękkie oświetlenie, gdy możliwe, minimalizujcie pipy, oferujcie cichy pokój, unikajcie silnych zapachów/perfum (Autism Spectrum News; CHOP).
- **Komunikujcie się dosłownie i konkretnie**: wyjaśniajcie każdy krok *przed* wykonaniem; mówcie, co macie na myśli; unikajcie figur retorycznych; sprawdzajcie zrozumienie prosząc osobę o parafrazę; **pozwalamcie długie cisze na przetwarzanie**.
- **Nie wymuszajcie kontaktu wzrokowego**; pozwalajcie osobie patrzeć w bok, stimować lub komunikować się na piśmie/klawiaturą/AAC.
- **Idźcie powoli; oferujcie przerwy**. Miejcie sensoryczny zestaw dystrakcji dostępny (CHOP).
- **Szanujcie tunel uwagi**: jeśli osoba używa zainteresowania lub stimu do samoregulacji podczas zabiegu, nie przerywajcie.
- Stosujcie **postawę podwójnej empatii** (Milton, 2012; Neurodivergent Insights): jeśli komunikacja się zacina, zakładajcie *wzajemną* lukę i adaptujcie się, raczej niż etykietując pacjenta „trudnym” lub „non-compliant”.

Po wizycie

- Dostarczajcie **pisemną kontynuację** (diagnoza, instrukcje, kolejne kroki) w dosłownym języku.
- Włączcie **czas regeneracji** i ostrzeżcie, że osoba może potrzebować odpoczynku/shutdownu potem.
- Dokumentujcie skuteczne adaptacje w akcie, by były automatyczne następnym razem.

Klinicznie krytyczne rozpoznania

- **Autystyczny burnout to nie depresja.** Prezentuje się jako przewlekłe wyczerpanie, utrata umiejętności i zmniejszona tolerancja na bodziec, napędzane przez kumulatywne obciążenie i niedopasowanie oczekiwań–zdolności; traktowanie go jako depresji (lub pchanie pacjenta, by „próbował mocniej”) może go pogłębić i ryzykować samobójczość. Regeneracja wymaga zmniejszonych żądań, akceptacji i pozwolenia na odmaskowanie (Raymaker et al., 2020).
- **Maskowanie w klinice jest częste i kosztowne.** Pacjent, który „wydaje się dobrze” na 15-minutowej wizycie, może kamuflować i płacić za to potem; nie pozwalajcie maskowanej prezentacji przeważać nad samoopisem lub historią (Pearson & Rose, 2021; F. Murray, 2023).
- **Ból i interocepcja.** Monotropowa osoba może nie zauważyć lub zgłosić ból, głód, pragnienie, zmęczenie lub wewnętrzne objawy, aż będą ciężkie (Kelly Mahler, 2024; Lawson). Nie równajcie „nie narzekania” z „nie cierpieniem”; pytajcie proaktywnie i rozważcie, że raportowane wzorce objawów mogą być opóźnione lub atypowe.
- **Leki i efekty uboczne.** Ludzie autystyczni często raportują atypowe sensoryczne i emocjonalne reakcje na leki; zaczynajcie nisko, tytrujcie powoli i monitorujcie samoopis ostrożnie.
- **Meltdown/shutdown w klinice.** Te są nieświadome: redukujcie stymulację, obniżajcie żądania, zapewnijcie bezpieczeństwo, dajcie czas i przestrzeń, nie powstrzymujcie i nie karajcie; wycofanie/shutdown potrzebuje spokojnej, niskie-input cierpliwości, nie presji na „angażowanie się” (Autism Society, 2025; Leicestershire Partnership NHS Trust; Reframing Autism).
- **Zgoda i zdolność.** Dostarczajcie informacje w dostępnej, dosłownej formie; pozwalajcie czas przetwarzania i wspomaganą decyzyjność;

nigdy nie zakładajcie braku zdolności z atypowej komunikacji.

- **Adaptacje pomagają wszystkim.** Sensorycznie przyjazna, przewidywalna, jasno komunikowana opieka także przynosi korzyść pacjentom z ADHD, PTSD, lękiem, stratą sensoryczną, zmianą kognitywną i wieloma innymi (UNC Health, 2025).

Część 5 — Czego unikać (częsta szkoda)

- Gwałtowne wyciąganie osoby z tunelu uwagi lub powtarzające się przerywanie flow (F. Murray, 2023).
- Odtresowywanie stimów, różnic kontaktu wzrokowego lub naturalnej komunikacji (oparta na complyansie „normalizacja”) — zwiększa maskowanie i długoterminową szkodę (F. Murray, 2023; Raymaker et al., 2020).
- Ramowanie specjalnych zainteresowań jako „obsesji” do ograniczania; redukowanie dostępu do zainteresowań (Mantzalas et al., 2022).
- Narzucanie rutyn/oczekiwań *nad* osobą raczej niż współtworzenie ich (F. Murray, 2022).
- Używanie opartego na deficycie, patologizującego języka; przypisywanie wszystkich problemów interakcji osobie autystycznej (Milton, 2012).
- Traktowanie autystycznego burnoutu jako depresji lub lenistwa; pchanie osoby do większego maskowania (Raymaker et al., 2020).
- Sensorycznie wrogie kliniki, procedury niespodzianki i niejasne instrukcje (PMC11305600; AASPIRE).
- Zakładanie, że lifelong'owe różnice starszego dorosłego to „tylko starzenie się” lub demencja bez odpowiedniej oceny (Klein et al., 2024).

Część 6 — Otwarte pytania i zastrzeżenia evidencji (dla uczciwej praktyki)

1. **Późna dorosłość jest luką badawczą.** Większość wytycznej na przestrzeni życia dla seniorów jest extrapolowana; autyzm + demencja, autyzm + menopauza/andropauza i opieka na końcu życia

- są w dużej mierze niezbadane (Klein et al., 2024). Bądźcie transparentni o niepewności z pacjentami i rodzinami.
2. **Monotropizm jest deskryptywny, jeszcze nie mechanistyczny ani w pełni testowany.** Jest doskonałą kliniczną heurystyką z rosnącym zbieżnym wsparciem, ale nie diagnozą ani kompletną teorią (Dwyer, 2021; 2025).
 3. **Nie wszystkie osoby autystyczne są monotropowe.** Mniejszość nie identyfikuje się z ramami; zawsze centrujcie jednostkę (monotropism.org).
 4. **Intersekcjonalność jest niedostatecznie adresowana.** Większość badań jest biała, zachodnia, werbalna i zaniżona-niższego-wsparcia-potrzeb-biased; prezentacje, diagnoza i potrzeby różnią się między płcią, rasą, zdolnością intelektualną i profilami komunikacji (Raymaker et al., 2020 ograniczenia).
 5. **Współwystępowanie jest regułą.** ADHD (AuDHD), lęk, depresja, różnice uczenia się, warunki GI/sen powszechnie współwystępują; monotropizm może pomóc wyjaśnić nakładanie AuDHD, a wyniki Monotropism Questionnaire są najwyższe w AuDHD (Garau et al., 2023; NAS, 2025).
-

Źródła

1. Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism. *Autism*, 9(2), 139–156.
<https://doi.org/10.1177/1362361305051398> — via <https://monotropism.org/murray-lesser-lawson>
2. Murray, F. (2018, aktualizowane 2025). Me and Monotropism: a unified theory of autism. *The Psychologist*, BPS.
<https://www.bps.org.uk/psychologist/me-and-monotropism-unified-theory-autism>
3. Murray, F. (2023). Monotropism and Wellbeing (keynote, Scottish Autism Research Group 2023). <https://monotropism.org/wellbeing>
4. Murray, F. (2019). Monotropism at School (początkowo w *Tes*).
<https://monotropism.org/school/> — indeksowane na <https://monotropism.org/in-practice>
5. Murray, F. (2022). Understanding how routines can help autistic people thrive. *Thinking Person's Guide to Autism*.

- <https://thinkingautismguide.com/2022/04/understanding-how-routines-can-help-autistic-people.html>
6. National Autistic Society (Edgar, H. & Adkin, T., 2025). What is monotropism? Understanding a neuroaffirming theory of autism. <https://www.autism.org.uk/learn/knowledge-hub/professional-practice/what-is-monotropism>
 7. Dwyer, P. (2021). Revisiting monotropism. *Autistic Scholar*. <https://www.autisticscholar.com/monotropism/>
 8. Dwyer, P. (2025). Monotropism: between obsessive joy and overwhelm. OTARC Blog, La Trobe University. <https://otarc.blogs.latrobe.edu.au/monotropism-between-obsessive-joy-and-overwhelm>
 9. Garau, V. et al. (2023). Development and validation of a novel self-report measure of monotropism (the Monotropism Questionnaire). OSF preprint. <https://osf.io/ft73y/> — narzędzie na <https://dlcincluded.github.io/MQ/>
 10. Landry, R. & Bryson, S. (2004). Impaired disengagement of attention in young children with autism. *J Child Psychol Psychiatry*, 45(6), 1115–1122. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2004.00304.x>
 11. Sacrey, L.-A. et al. (2015). Attention disengagement in autism spectrum disorder: a meta-analysis. *Neurosci Biobehav Rev*, 56, 111–121. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2014.10.011>
 12. Heasman, T. et al. (2024). Autistic flow theory. (Zacytowane w NAS, 2025.)
 13. Raymaker, D. M. et al. (2020). "Having all of your internal resources exhausted beyond measure and being left with no clean-up crew": defining autistic burnout. *Autism in Adulthood*, 2(2), 132–143. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32851204> — pełny tekst: https://pdxscholar.library.pdx.edu/socwork_fac/378
 14. Mantzalas, J. et al. (2022). A conceptual model of risk and protective factors for autistic burnout. *Autism Research*. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aur.2722>
 15. Pearson, A. & Rose, K. (2021). A conceptual analysis of autistic masking: understanding the narrative of stigma and the illusion of choice. *Autism in Adulthood*, 3(1). <https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/aut.2020.0043>

16. Bradley, L. et al. (2021). Autistic adults' experiences of camouflaging and its perceived impact on mental health. *Autism in Adulthood*, 3(4), 320–329. (PubMed 36601637.)
17. Milton, D. (2012). On the epistemic and ontological value of the double empathy problem. *Dis & Soc.* Podsumowanie: Reframing Autism, <https://reframingautism.org.au/miltons-double-empathy-problem-a-summary-for-non-academics>
18. Lawson, W. (2011). *The Passionate Mind: How People with Autism Learn*. Jessica Kingsley. — i Lawson, W. (2025). Research by autistic researchers: an 'insider's view' into autism. *Frontiers in Psychiatry*, 16, 1664507. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12586063/>
19. Wood, R. (2019). Autism, intense interests and support in school: from wasted efforts to shared understandings. *Educational Studies*. Podsumowanie: <https://woodbug.blog/2019/03/27/autistic-children-and-intense-interests-the-key-to-their-educational-inclusion/>
20. Wood, R. et al. (2022). *Learning From Autistic Teachers*. Jessica Kingsley.
21. Leatherland, J. (2019). Understanding how autistic pupils experience secondary school (praca doktorska, Sheffield Hallam). <http://shura.shu.ac.uk/23231/>
22. Kasari, C., Freeman, S., & Paparella, T. (2006). Joint attention and symbolic play in young children with autism: a randomized controlled intervention study. *J Child Psychol Psychiatry*, 47, 611–620. (Referowane via PMC5683273.)
23. Donzelli, S. (2021). Autistic play at forest school: pretend play characteristics seen otherwise. *Forest School Association*. <https://forestschoollassociation.org/autistic-play-at-forest-school-pretend-play-characteristics-seen-otherwise/>
24. Hallett, S. (2021). Loops of concern (przewodnik o autystycznej ruminacji). <https://medium.com/@sonyahallett/loops-of-concern-ff792eebad03>
25. Kelly Mahler (2024). Interoception and monotropism. <https://www.kelly-mahler.com/resources/blog/interoception-and-monotropism-paying-attention-to-autistic-adhd-experiences/>
26. Knight, J. (2021). Staying put, monotropism & me (tunnels not tasks); (2022) Applying monotropism.

- <https://spacedoutandsmiling.com/blog/2021-11-27-staying-put-monotropism-me>
27. Booth, J. (2021). Why does work not work for autistic people? <https://janinebooth.com/content/why-does-work-not-work-autistic-people>
 28. BERA (2021). Autism: the benefits of monotropism and flow states and its applications for the classroom. <https://www.bera.ac.uk/blog/autism-the-benefits-of-monotropism-and-flow-states-and-its-applications-for-the-classroom>
 29. Autism Society (2025). Autistic meltdowns and shutdowns (brozura). <https://autismsociety.org/>
 30. Leicestershire Partnership NHS Trust — Autism Space. Understanding autistic meltdowns and shutdowns. <https://www.leicspart.nhs.uk/autism-space/health-and-lifestyle/meltdowns-and-shutdowns>
 31. Reframing Autism. All about autistic shutdowns: a guide for allies. <https://reframingautism.org.au/all-about-autistic-shutdown-guide-for-allies>
 32. AASPIRE Healthcare Toolkit / Autism Healthcare Accommodations Tool (AHAT). <https://autismandhealth.org>
 33. Children's Hospital of Philadelphia (CHOP). Tips for more positive office visits for patients with ASD. <https://www.chop.edu/news/tips-more-positive-office-visits-patients-asd>
 34. UNC Health (2025). Autistic patients need better care, accommodations in the medical office. <https://news.unchealthcare.org/2025/04/autistic-patients-need-better-care-accomodations-in-the-medical-office>
 35. Autism Spectrum News. Creating sensory-friendly health care environments for autistic patients. <https://autismspectrumnews.org/creating-sensory-friendly-health-care-environments-for-autistic-patients>
 36. Klein, C. B. et al. (2024). Aging well and autism: a narrative review and recommendations for future research. *Healthcare*, 12(12), 1207. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11203987> — <https://doi.org/10.3390/healthcare12121207>
 37. Organization for Autism Research (OAR). Aging on the autism spectrum. <https://researchautism.org/oaracle-newsletter/aging-on-the-autism-spectrum>

38. Lai, M.-C. & Baron-Cohen, S. (2015). Identifying the lost generation of adults with autism spectrum conditions. *Lancet Psychiatry*. (Referowane w Klein et al., 2024.)
39. Edgar, H. (2023). Supporting pupils through autistic burnout (przewodnik dla nauczycieli). <https://autisticrealms.com/supporting-pupils-through-autistic-burnout-teacher-guide/>
40. Edgar, H. (2024). Autistic young people: skills regression, burnout or a shift in monotropic attentional resources? <https://autisticrealms.com/autistic-young-people-skills-regression-burnout-or-a-shift-in-monotropic-attentional-resources/>
41. Autism Awareness Australia. Understanding mental health in autistic teenagers. <https://www.autismawareness.com.au/navigating-autism/understanding-mental-health-in-autistic-teenagers>
42. Autism Research Institute (ARI). Understanding and supporting puberty in autistic girls and boys. <https://autism.org/understanding-and-supporting-puberty>
43. Neurodivergent Insights. Autism and the double empathy problem in medicine. <https://neurodivergentinsights.com/the-double-empathy-problem-in-medicine>
44. PieBru (2025). Monotropism: an interest-based account of autism (przegląd źródłowy). <https://github.com/PieBru/monotropism/blob/main/monotropism.md>
45. Narrative review: Autism-friendly healthcare — a narrative review of the literature (PMC11305600). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11305600>

Wspierające zasoby praktyczne (cytowane inline powyżej dla praktycznych twierdzeń niższej stawki)

- Advanced Autism Services (2025). How to support autistic adults in the workplace. <https://www.advancedautism.com/post/how-to-support-autistic-adults-in-the-workplace>
- Sachs Center. Autism workplace accommodations that actually work. <https://sachscenter.com/autism-workplace-accommodations>
- Links ABA. Accessing healthcare as an autistic individual; work and mental health tips for autistic adults. <https://linksaba.com>
- Autism Little Learners. Transitions and autism; smoother transitions in young autistic kids. <https://autismlittlelearners.com>

- Grateful Care ABA. Preparing for doctor visits with autism.
<https://www.gratefulcareaba.com/blog/preparing-for-doctor-visits-with-autism>
- ABTABA / Above and Beyond Therapy. Autism aging out; autism shutdown. <https://www.abtaba.com>
- Additude. Aging with autism: cognition, health, loneliness & other factors. <https://www.additudemag.com/aging-with-autism-research>
- Retireguide. Aging with autism: a seniors & caregivers guide.
<https://www.retireguide.com/guides/seniors-autism-spectrum>
- Raising Children Network (Australia). Self-identity for your autistic teen. <https://raisingchildren.net.au/autism>
- Autistic Realms (Edgar, H.). Monotropism = happy flow state.
<https://autisticrealms.com/monotropism-happy-flow-state>
- Neurodiverse Connection. Embracing autistic children's monotropic flow states. <https://ndconnection.co.uk/blog/embracing-autistic-childrens-monotropic-flow-states>